

prise en charge Hypertension [$>140/90$]

Monothérapie : IEC
 → ARA2 si toux Δ AINS → IR

Non compatibles grossesse

Bithérapie : [IEC ; ARA2] + [IC ; Diurétique Thiazidique]

Non grossesse

Trithérapie : [IEC ; ARA2] + IC + Diurétique Thiazidique

Non grossesse

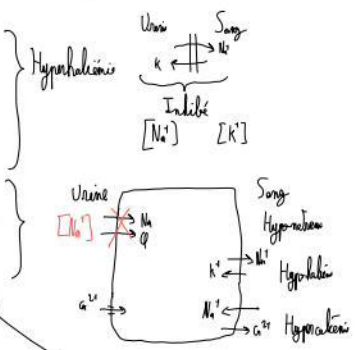
Quadrithérapie : [IEC ; ARA2] + IC + Diurétique Thiazidique + [Spironolactone ; α bloq ; β bloq ; diurétique...]

Toujours l'un ou l'autre

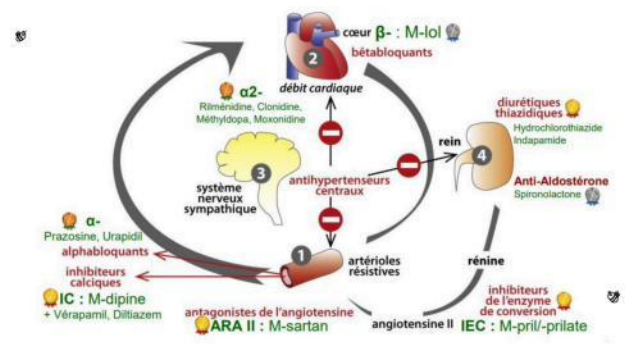
Jamais IEC + Sartans

Si projet de grossesse → β-bloquant

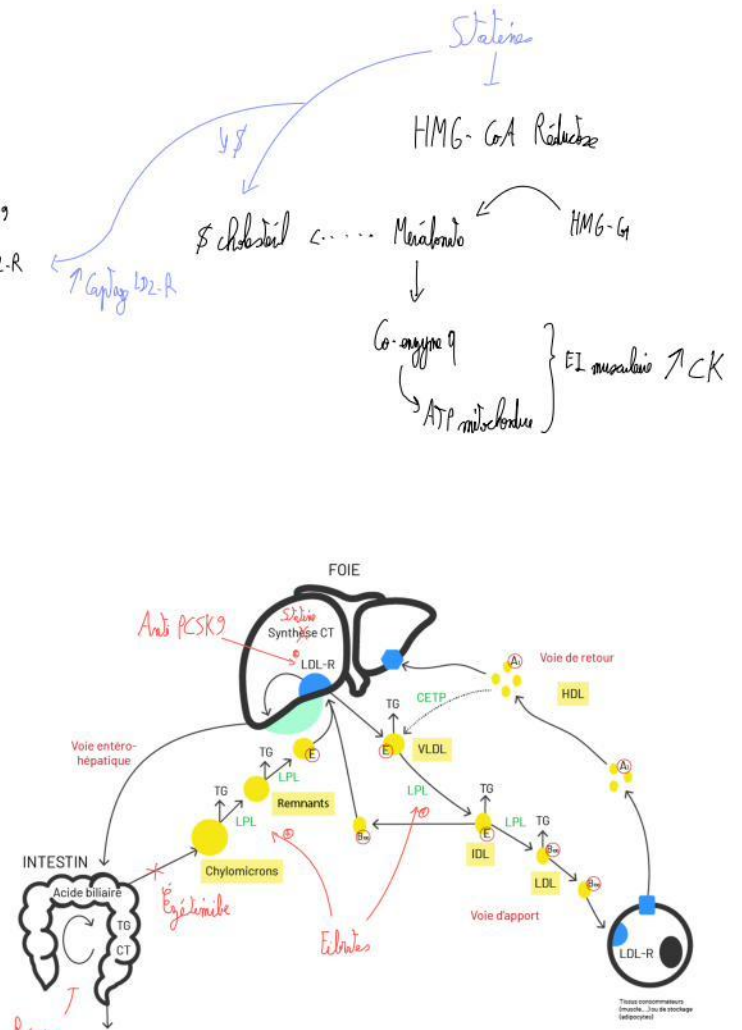
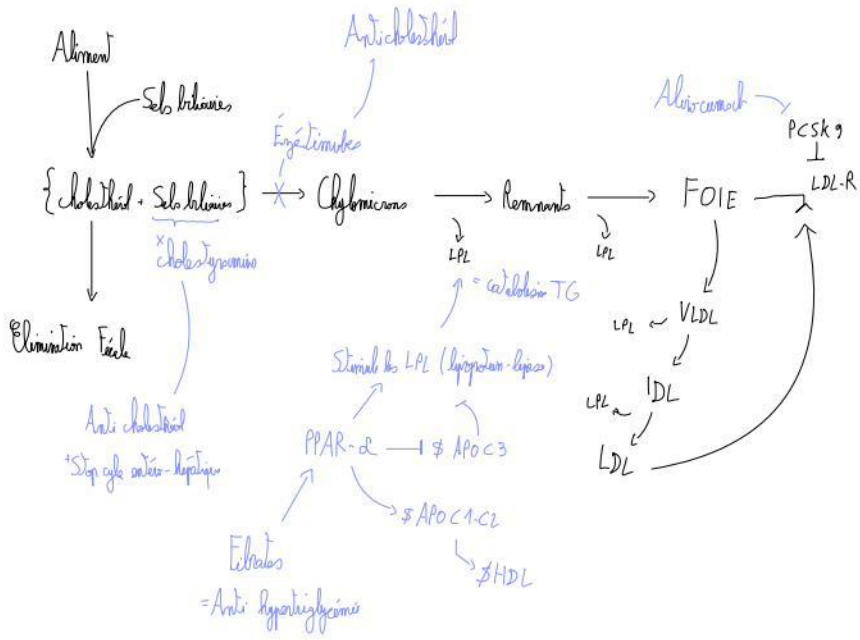
- Valsartan (antagoniste des récepteurs à l'angiotensine 2 (ARA2), famille des sartans) a pour effets indésirables : hypotension, hyperkaliémie, insuffisance rénale fonctionnelle.
- Captopril (inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC), termine en -pril/prilate) a pour effets indésirables : hypotension, hyperkaliémie, insuffisance rénale fonctionnelle, toux.
- Hydrochlorothiazide (diurétique thiazidique) a pour effets indésirables : hyponatrémie, hypokaliémie, hypercalcémie, troubles métaboliques dont hyperglycémie et hyperuricémie.
- Nifédipine (inhibiteur calcique, famille des -dipines) a pour effets indésirables : céphalées, vertiges, flushs, œdèmes des membres inférieurs.
- Propranolol (β bloquant) a pour effets indésirables : asthénie, bradycardie sinusale, acrosyndrome, troubles de la libido, dysfonction érectile.
- Spironolactone (diurétique antagoniste de l'aldostérone) a pour effets indésirables : hyperkaliémie, gynécomastie, dysménorrhée.



IC = diurétique osmotique dont action osmotique = céphalée



Triglycérides ↓ Cholestérol



Cholestérolémie = Résine